기운이 떨어진다면 생활기능을 함께 살펴요

노쇠·식사·움직임·약·돌봄을 함께 보는 진료

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

검사 수치만으로 몸의 상태를 다 알 수는 없습니다

혈당·혈압이 잘 조절되어도 생활기능이 떨어질 수 있습니다

병과 기능은 함께 봅니다

노인에서는 여러 질환과 낮은 예비력이 겹칠 수 있습니다. 탈수·감염·수술 같은 스트레스가 더해지면 몸의 기능이 급격히 나빠지기도 합니다.

나이와 병 개수만으로 판단하지 않습니다

같은 나이라도 걷기·식사·일상생활 능력은 다릅니다. 질환별 치료와 함께 노쇠(frailty), 즉 스트레스를 견디고 회복할 여력이 줄었는지 살펴야 합니다.

혈당·혈압이 잘 조절되어도 생활기능이 떨어질 수 있습니다

노쇠는 몸의 회복 여력이 줄어든 상태입니다

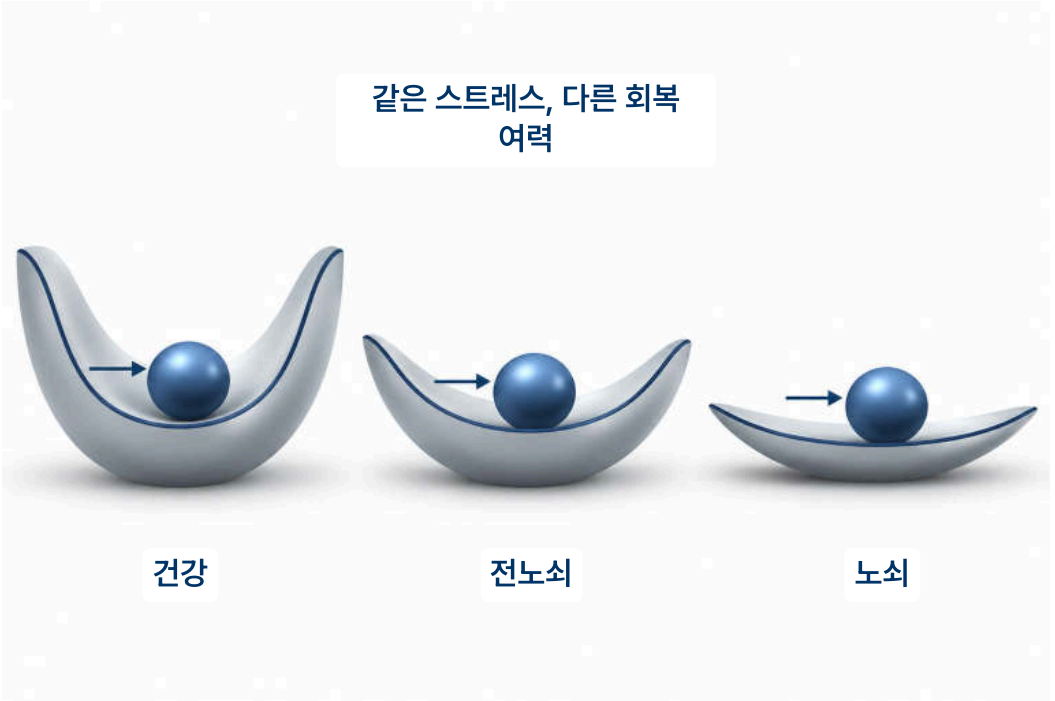
같은 스트레스에도 받는 영향이 달라질 수 있습니다

노화와 노쇠는 다릅니다

노화(aging)는 몸에서 일어나는 생물학적 변화입니다. 노쇠는 변화가 쌓이면서 시스템 전체가 취약해지고, 기능 저하로 드러나는 상태를 말합니다.

예방과 이른 중재가 중요합니다

건강한 상태·전노쇠·노쇠 단계는 스트레스를 견디는 여력이 다릅니다. 기능 저하가 뚜렷해지기 전부터 살피는 것이 중요하며, 노쇠 단계에서도 문제가 있는 영역에 중재할 수 있습니다.



같은 스트레스에도 받는 영향이 달라질 수 있습니다 · 설명용 도식

> 같은 스트레스에도 받는 영향이 달라질 수 있습니다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

먼저 간단히 살피고, 필요하면 자세히 평가합니다

노인포괄평가(CGA)는 도울 수 있는 영역을 찾는 과정입니다

1

변화 듣기

걸음·피로·식사·체중·도움이 필요한 일 등 평소와 달라진 점을 듣습니다.

2

노쇠 선별

임상노쇠척도(CFS) 같은 도구로 진료실에서 노쇠 가능성을 살핍니다.

3

포괄평가

노쇠가 의심되면 질병뿐 아니라 약·영양·정서·인지·기능·돌봄을 평가합니다.

4

중재 연결

점수만 매기고 끝내지 않고, 부족한 영역을 보완할 진료와 돌봄 계획을 정합니다.

노인포괄평가(CGA)는 도울 수 있는 영역을 찾는 과정입니다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

생활에서 필요한 도움의 종류를 알려주세요

걷는 모습과 실제 생활을 함께 묻습니다

기본 일상생활 · ADL

식사나 위생관리 등 기본적인 생활에 다른 사람의 도움이 필요한지 살핍니다. 도움의 유무와 정도는 노쇠 정도를 구분하는 중요한 정보입니다.

도구적 일상생활 · IADL

기본 생활은 가능해도 더 복잡한 일상활동에 도움이 필요할 수 있습니다. 연자는 ADL과 IADL을 추가로 질문해 CFS 4·5·6점의 경계를 구분한다고 설명했습니다.

걷는 모습과 실제 생활을 함께 묻습니다

노쇠 평가는 여러 영역을 한 번에 살핍니다

몸·마음·일상·주변 도움을 함께 봅니다

함께 살피는 영역

질병과 복용약, 우울과 인지, 영양, 신체 활동 능력, 기본·도구적 일상생활 능력, 사회적 돌봄 자원이 노인포괄평가에 포함됩니다.

전체를 보아야 계획이 보입니다

질병 수치가 좋아도 다른 영역에 문제가 남을 수 있습니다. 약을 조정하고 영양을 보충하며 움직임과 돌봄을 함께 지원하는 등, 여러 영역의 부족분을 함께 채우는 접근입니다.



몸·마음·일상·주변 도움을 함께 봅니다 · 설명용 도식

> 몸·마음·일상·주변 도움을 함께 봅니다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른 내과

노쇠 점수는 치료와 돌봄 계획을 돕습니다

점수 하나로 앞으로의 삶을 단정하지 않습니다

구분	설명
CFS · 1~9점	임상노쇠척도: 보행 상태와 생활기능 등을 진료진이 종합해 선별합니다.
CFS · 4점	강의에서는 전노쇠 단계로 설명합니다.
CFS · 5점 이상	강의에서는 노쇠로 보고 다면적 평가와 중재를 강조합니다.
노쇠지수 · FI	문제가 있는 평가 항목 수 ÷ 전체 평가 항목 수입니다.
FI · 0.25	강의 예: 40개 중 10개 항목에 문제가 있으면 0.25입니다. ≥0.25를 노쇠로 설명합니다.

점수 하나로 앞으로의 삶을 단정하지 않습니다

식사와 움직임의 변화도 진료할 내용입니다

영양과 신체 활동 능력은 서로 연결된 평가 영역입니다

식사·체중

식사량이 줄었는지, 체중이 줄었는지, 영양 상태가 어떤지 살핍니다. 영양이 부족하면 경구영양보충제(ONS) 등 보충 방법을 진료에서 고려합니다.

걷기·활동·낙상

보행 상태, 신체 활동 능력, 최근 낙상과 어지럼증을 함께 확인합니다. 식사 보충만이 아니라 신체 능력과 생활기능도 함께 평가하고, 필요한 운동·재활 프로그램으로 연결합니다.



영양과 신체 활동 능력은 서로 연결된 평가 영역입니다 · 설명용 도식

영양과 신체 활동 능력은 서로 연결된 평가 영역입니다

여러 약이 겹치면 어지럼·낙상과 관련될 수 있습니다

질병 조절과 약의 부담을 함께 살핍니다

항콜린약

어지럼증·인지 변화와 관련될 수 있는 약제를 점검합니다.

항경련제

뇌에 작용하는 약들의 조합을 함께 살핍니다.

항정신병약

여러 종류가 겹쳐 처방됐는지 살핍니다.

수면·진정제

벤조디아제핀과 Z-drug 계열을 점검합니다.

항우울제

TCA·SSRI·SNRI 등 복용약을 함께 봅니다.

오피오이드 진통제

강의는 CNS-active drugs 3종 이상에서 섬망·낙상 위험 증가를 강조했습니다.

질병 조절과 약의 부담을 함께 살핍니다

약은 전체 목록을 보고 진료진이 조정합니다

식사·체중·신체 능력과 약의 이득을 함께 봅니다

조정할 내용을 찾습니다

중추신경계 약과 항콜린약의 중복, 복용 시간, 영양과 체중에 미치는 영향 등을 함께 점검합니다. 강의는 감량·복용 시간 변경·다른 계열로 변경하는 접근을 소개했습니다.

개인에게 맞는 조정입니다

강의의 약 변경은 개별 증례에서 시행한 판단입니다. 특정 계열의 약을 모든 노인에게 일괄 중단한다는 뜻이 아닙니다. 약 조정과 영양 보충, 생활 지원을 함께 묶어 계획합니다.

식사·체중·신체 능력과 약의 이득을 함께 봅니다

살던 곳에서 지내도록 의료와 돌봄을 연결합니다

강의에서 소개한 2026 지역사회 통합돌봄입니다

누가 도움을 받을까요

노쇠·장애·질병 등으로 일상생활 유지가 어렵고 복합적인 지원이 필요한 분을 대상으로 설명합니다. 장기요양 재가급여자, 돌봄 중점군, 입원·입소 경계의 65세 이상 퇴원환자 등이 우선 대상입니다.

어떤 목적일까요

2026년 3월 27일 시행된 제도로 강의에서 소개됐습니다. 살던 곳에서 건강한 생활을 이어가도록 의료·요양·돌봄·복지를 통합하고 연계하는 것이 목적입니다.



강의에서 소개한 2026 지역사회 통합돌봄입니다 · 설명용 도식

> 강의에서 소개한 2026 지역사회 통합돌봄입니다

도움은 네 가지 영역으로 이어집니다

필요도에 따라 개인별 지원계획으로 연결합니다

보건의료

방문진료·왕진버스, 정신건강·치매 관리, 퇴원환자 지원, 만성질환 관리, 통합재택간호, 임종 돌봄

건강관리

노쇠예방 관리, 복약지도, 운동 프로그램, 스마트기기를 이용한 건강관리

장기요양

방문간호·요양·목욕, 영양·재활, 주야간·단기보호, 재택의료, 통합재가, 병원동행

일상돌봄

긴급돌봄, 독거노인 응급안전, 주거환경 개선과 스마트홈 돌봄

필요도에 따라 개인별 지원계획으로 연결합니다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

돌봄 신청 뒤에도 상태에 따라 계획을 바꿉니다

신청 → 조사 → 계획 → 연계 → 모니터링

1

신청

읍면동 행정복지센터나 건강보험공단 지사 등에서 신청합니다.

2

조사

의료·요양·돌봄의 필요도를 종합적으로 살핍니다.

3

계획

필요도에 따라 개인별 지원계획을 세웁니다.

4

연계

보건의료·건강관리·장기요양·일상생활 지원으로 연결합니다.

5

모니터링

상태 변화를 살피고 필요하면 지원계획을 변경합니다.

신청 → 조사 → 계획 → 연계 → 모니터링

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

장기요양 서비스도 함께 상의할 수 있습니다

노쇠 정도와 실제 생활의 어려움을 진료에서 알려주세요

구분	설명
방문요양	집에서 신체활동과 일상생활을 지원
방문목욕·방문간호	목욕과 간호, 진료 보조 및 요양 관련 상담 지원
주야간·단기보호	일정 시간 또는 기간 동안 보호와 활동 지원
진료에서 연결	연자는 CFS 5·6점 정도에서 돌봄 필요를 살펴 장기요양 또는 통합돌봄 연계를 강조
평가와 신청	CFS는 노쇠 선별 도구이며, 서비스 등급의 신청·판정 과정과 구별합니다.

노쇠 정도와 실제 생활의 어려움을 진료에서 알려주세요

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

진료 때는 생활의 변화를 함께 말씀해주세요

좋아지는지 볼 때도 검사 수치와 생활기능을 함께 봅니다

01 몸의 변화

식사량·체중·걷기·활동량·어지럼증·낙상이 어떻게 달라졌는지 알립니다.

02 마음과 기억

우울감, 기억이나 인지의 변화도 함께 이야기합니다.

03 복용약

여러 곳에서 받는 약과 실제 복용 시간을 한꺼번에 점검합니다.

04 도움의 변화

일상에서 혼자 하기 어려운 일과 가족·주변의 도움을 알립니다.

좋아지는지 볼 때도 검사 수치와 생활기능을 함께 봅니다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

내 상태에 맞는 다음 진료를 함께 정합니다

노쇠·식사·움직임·약·돌봄을 함께 보는 진료

전화

031-893-4560

주소

경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298,
4층 402-404호

진료시간

평일(월–금) 08:30~18:30
점심 13:00~14:00 · 토 08:30~13:30
일·공휴일 휴진

진료과

소화기내과 · 일반내과 · 5대암 검진

광교바른내과
진료 설명자료

광교바른내과 · 환자·보호자 설명자료